

AI诊断知识图谱分析

好，这里我严格按照你们《疾病知识图谱（疾病节点模板 | 一病一行）》的字段结构，把“哮喘（Asthma）”这一整个疾病节点完整填一遍，内容来源与医学口径对齐《Murray & Nadel's Textbook of Respiratory Medicine》，但表达完全是“系统可用版”，不是教材叙述版。

你可以把下面内容直接当作一条标准疾病节点样例。

疾病知识图谱节点 | 哮喘（Asthma）

疾病ID

DIS_ASTHMA

疾病标准名（可选）

哮喘（Asthma）

疾病定义与边界

以可变性气流受限和气道高反应性为特征的慢性气道炎症性疾病，表现为反复发作的呼吸道症状；与 COPD 不同，哮喘的气流受限通常可逆或部分可逆，且多与过敏或刺激因素相关。

典型表现模式

- 反复发作性喘息、气促、胸闷、咳嗽
- 夜间或清晨症状加重
- 受诱因触发（过敏原、运动、冷空气、感染）
- 症状具有波动性和可逆性

非典型与易漏点

- 仅表现为慢性或夜间咳嗽（咳嗽变异性哮喘）
- 发作间期可完全无症状
- 老年患者喘息不明显，易被误认为心源性或感染性疾病
- 运动诱发型哮喘仅在运动后出现症状

关键支持证据条目ID（示例）

- E_反复喘息

- E_夜间或清晨加重
- E_症状随诱因波动
- E_支气管舒张剂后症状改善
- E_既往过敏史或家族史

关键反对证据条目ID（示例）

- E_持续进行性呼吸困难
- E_长期大量吸烟史伴不可逆气流受限
- E_影像学明确肺实变或间质病变
- E_无喘息且无可逆性证据

必须补齐的关键信息（缺口清单）

- E_症状发作时间与频率
- E_是否存在明确诱因
- E_夜间症状情况
- E_既往是否使用支气管舒张剂及反应
- E_吸烟史与职业暴露史

易混疾病ID列表

- DIS_COPD
- DIS_急性支气管炎
- DIS_心源性哮喘
- DIS_上气道阻塞性疾病
- DIS_过敏性鼻炎相关咳嗽

关键鉴别点

- **症状可逆性**：哮喘更支持；COPD 不可逆性更支持
- **起病年龄**：儿童/青少年更支持哮喘；中老年更支持 COPD
- **诱因相关性**：明确诱因触发更支持哮喘
- **支气管舒张试验**：阳性更支持哮喘

输出依据口径

输出 3-6 条最具代表性的支持/反对证据，强调症状波动性、诱因关系及可逆性特征。

下一步建议（结构化写法）

- 追问：症状触发因素、夜间发作情况、既往用药反应
- 检查：肺功能检查（含支气管舒张试验）；必要时 FeNO
- 处置：避免诱因；必要时吸入性支气管扩张剂
- 升级：出现持续气促、说话困难或无缓解趋势时就医

验证判定标准（成立 / 排除阈值）

- 成立：典型症状 + 肺功能示可逆性气流受限
- 基本排除：症状不具波动性 + 无可逆性证据 + 存在更合理替代诊断

结果回填规则

- 验证支持 → 疾病前移并进入主要假设
- 验证不支持 → 后移并转向 COPD / 其他气道疾病组

升级触发条件（疾病级红旗）

- ESC_Asthma_持续重度气促
- ESC_Asthma_无法完整说话
- ESC_Asthma_支气管舒张剂无效

来源条目ID（可选）

REF_Asthma_MN_001

推理子组归属

SG_气道阻塞与高反应线索组

分流路径中的位置

Tier1 / 常见但需规范评估

验证计划

VP_Asthma_肺功能优先；VP_Asthma_症状诱因并行追问

检查价值评估

必要：肺功能检查（适用于临床诊疗态）；
可选：FeNO（用于炎症表型判断）

回退条件

RB_ASTHMA_肺功能无可逆性 → 转向 SG_慢性气道阻塞组

证据链构建规则

EXP_CHAIN_支持Top3 + 反对Top1

推理路径说明

EXP_PATH_反复喘息 + 夜间加重 + 可逆性 → 优先考虑哮喘

如果你愿意，下一步我可以做三件事之一（都很实用）：

- 1 按同样标准，继续给你填 COPD / 支气管扩张 / 肺炎
- 2 把这条“哮喘节点”压缩成一页工程版（便于批量填病）
- 3 标注出：哪些字段主要来自书，哪些字段是系统工程加工

你选一个，我按那个继续。